

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231696384 | 597

GUIOMAR DINIZ DA SILVA

IDADE: 75 PESO: 75 ALTURA: 1,62 PROFISSÃO: Costureira (Aposentada)

SINTOMAS: Pausas e engargalos presenciados,

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Puram / Brasat / Alodipina / Delina / Concordia /
Simvastatina / Dapa qifosina / Tiroxina / Koli / Nexina / Itangit

MÉDICO: Dr. Ruffel Antonio F.

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x Hidre e along.

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: — JANTAR: 18-19h

HORA QUE DORME: 00h HORA QUE ACORDA: 6h-7h

COCHILLO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: não

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: II

IAH: 57,5elh SPO2: 67%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS / Diabetes

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N SPO2 C/ CPAP: 86% PRESSÃO NO EXAME: 11cmH2O

23/10/24 Avaliação

31/10/24 P = 10,2 med. * Relata que não sente diferença pr as AVD's.
IAH = 6,6 elh
M. de uso = 24h26' sua
fuga = 24,8

* Coloca em Pressão fixa

13/11/24 P = 10,2 cmH2O

Bem adaptada

da ombro E

IAH = 0,8 elh

Silvia

m uso = 8h15'

vai avaliar compra na próx consulta

fuga = 29elmin

25/11/24 P=10,2 cmH₂O
IAH= 2,4 e/h
m de uso: 6h49'
fuga: 13,5 l/min

* Comprei CPAP Basico

Oriento sobre exercicio
de lingua no céu da
boca p/ vazamento

Natasha

18/12/24 P=10,2 cmH₂O
IAH= 1,1 e/h
m de uso: 7h20 min
fuga: 41,8 l/min

Silvia

05/02
2025 P=10,2 cmH₂O
IAH= 0,8 e/h
m de uso: 7h30
fuga: 30 l/min

Bem Adaptada.

* novo filtro *

Silvia

23/04
2025 P=10,2 cmH₂O
IAH= 0,6 e/h
m de uso: 7h35 min
fuga: 33 l/min

Bem adaptada / sem queixas

* novo filtro *

Silvia

22/07
2025 P=10,2 cmH₂O
IAH= 0,7 e/h
m de uso: 7h56 min
fuga: 35 l/min

Bem adaptada / quebrou dedão pé

* novo filtro *

Silvia

Nome: GUIOMAR DINIZ DA SILVA

Data de Nascimento: 26-7-1949

IMC: 29,30

Sexo: Feminino

Data do exame: 28-08-2024

Peso: 75 kg

Altura: 1,60 m

Médico: DR. KEFFEL ANTONIO
FERNANDES PEREIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 28-08-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 497,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 60,5 e 144,0 minutos. O tempo total de sono foi de 227,0 min, eficiência de 45,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,0%; estágio N2: 54,4%; estágio N3: 20,7%; sono REM: 22,9%. O índice de despertares foi de 5,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 3,2/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 12 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e a mínima de 86%, permanecendo 13,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 77 - 93 bpm e NREM de 76 - 93 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (1), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (59,7/hora);
6. presença de atividade em EMG de queixo;
7. registro de ronco durante o sono.

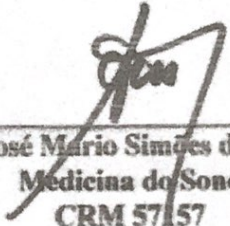
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 11,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: GUIOMAR DINIZ DA SILVA
Data de Nascimento: 26-7-1949
IMC: 29,30
Sexo: Feminino
Data do exame: 13-06-2024

Peso: 75 kg
Altura: 1,60 m
Médico: DR. KEFFEL ANTONIO
FERNANDES PEREIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 13-06-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 561,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 50,0 e 157,5 minutos. O tempo total de sono foi de 427,0 min, eficiência de 76,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 66,0%; estágio N3: 14,3%; sono REM: 17,2%. O índice de despertares foi de 35,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 57,5/hora, sendo 1 obstrutiva, 0 mistas e 0 centrais e 363 hipopnéias. A SpO2 média foi de 86% e a mínima de 67%, permanecendo 74,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 75 - 100 bpm e NREM de 52 - 94 bpm.

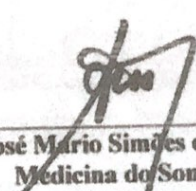
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 57,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=67%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57